



INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 16:10
Centro de atención: Z01 - Zaragoza
Paciente: CC 33146271 - MAXIMA BELLO BATISTA
Fecha de Nacimiento: 25/03/1940
Religión:
Régimen: 1 - Contributivo
Dirección: BRR PIEDRA DE BOLIVAR CLL PEDRO BARRIOS 26A - 51
Teléfono: 3134155310
Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO
OCUPACION
Grupo Poblacional:
Acompañante: MLIS MARTINEZ
Teléfono Acomp.: 3134155310
Dirección Acomp.:
Responsable:
Teléfono Resp.:
Dirección Resp.:
Médico Tratante: ARIEL ALONSO BELLO ESPINOSA
Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Fecha de Atención: 02/10/2024 16:34
Admisión: AD1005930

Edad: 84 año(s), 6 mes(es) 7 día(s)
Creencia:
Nivel: 1
Lugar: Cartagena Bolívar

Impreso por: AMRANDA

Sexo: F
Estado Civil: Soltero

Carnet:

Raza:

Etnia:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.: HIJA

Especialidad: MEDICINA INTERNA

Tipo Vinculación: Cotizante

EPICRISIS

DATOS DE LA CONSULTA

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias

Fecha de Ingreso: 19/09/2024 12:41

Cama: 4--11A

Motivo de la Consulta:

"LLEVA 3 DIAS CON FIEBRE Y LE DUELE EL ABDOMEN. SE SIENTE CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR"
FIEBRE DE 38.6

ANTECEDENTES:

PATOLÓGICOS: ARTRITIS REUMATOIDE

HOSPITALIZACIONES: NIEGA

QUIRÚRGICOS: APENDICECTOMÍA

FARMACOLÓGICOS: NIEGA

TÓXICOS: EX TYABAQUISTA

ALERGIAS: NIEGA

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE FEMENINA EN LA NOVENA DÉCADA DE LA VIDA, QUIEN INGRESA TRAÍDA POR FAMILIARES, REFIEREN CUADRO CLÍNICO DE APROXIMADAMENTE 4 DÍAS DE EVOLUCIÓN, CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS, ASOCIADO A SENSACIÓN DE MALESTAR GENERAL, AL INTERROGATORIO PACIENTE REFIERE CUADRO DE TOS SECA Y POLAQUIURIA/ORINA FÉTIDA DE APROX 10 DÍAS DE EVOLUCIÓN, A SU INGRESO SE HALLA EN REGULAR ESTADO GENERAL, FEBRIL (38.5°C) SIN EMBARGO TOLERANDO VO Y OXÍGENO AMBIENTE, AL EXAMEN FÍSICO, CON LEVE DOLOR A LA PALPACIÓN DE HIPOGASTRIO, SE DECIDE INGRESAR COMO FIEBRE EN ESTUDIO, SE INICIA MANEJO CON LEV, ANTIPIRÉTICOS IV Y SOLICITAN ESTUDIOS PARA CLÍNICOS, SE REVALORARÁ CON RESULTADOS.

Femenina de 84 años con antecedentes de FA, tabaquismo pesado, y artritis reumatoide con tratamiento inadherente con metotrexate quien ingresa por picos febriles y tos con expectoración de 1 mes de duración. Hemograma de ingreso con leucocitosis marcada e hiperbilirrubinemia. Función renal conservada. Al examen físico se valora paciente hemodinámicamente estable con signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral. Debido al estado de inmunosupresión del paciente, cuadro respiratorio e imágenes sugestivas se sospechó infección por tuberculosis. Se solicitaron paraclínicos para su posterior estudio de cuadro con reporte de 2 baciloscopias negativas para BAAR y PCR para M. tuberculosis negativa, por lo que se considera realización de fibrobroncoscopia. Dado el antecedente de artritis reumatoide se solicitó valoración por servicio de neumología para evaluar posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial asociado a patología inmune quienes indican fibrobroncoscopia + LBA para descartar probable micosis pulmonar e infecciones asociadas. Paciente en contexto de patología pulmonar intersticial, descartando de momento infección asociada por BAAR, con indicación ambulatoria de realización de estudios espirométricos, de volumen y fibrobroncoscopia, por lo cual, ante evolución favorable, se decide indicar, egreso con formula ambulatoria, control ambulatorio por especialidades tratantes con resultados de estudios solicitados. Se explica conducta a seguir a paciente quien refiere entender y aceptar

Revisión Por Sistema:

E/E

EXAMEN FÍSICO:

Apariencia a su llegada:

PACIENTE QUIEN INGRESA, CONSCIENTE, ALERTA, EN CONEXIÓN CON EL MEDIO, SE TORNA COLABORA A LA ENTREVISTA

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCÉFALO, CABELLO CON BUENA IMPLANTACIÓN, ISOCORIA CON ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA SIN LESIONES, AMÍGDALAS EUTRÓFICAS, CUELLO MÓVL, NO DOLOROSO, SIN MASAS NI MEGALIAS PALPABLES, NO INGURGITACIÓN YUGULAR

Tórax:

SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, SIN TIRAJES, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, SIN RUIDOS PATOLÓGICOS AGREGADOS, RSCS RÍTMICOS, SIN SOPLOS.

Abdomen:

GLOBOSO POR PANÍCULO, PERISTALSIS CONSERVADA, BLANDO, DEPRESIBLE, LEVE DOLOR A LA PALPACIÓN DE HIPOGASTRIO, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, NO MASAS O MEGALIAS PALPABLES, PUÑO PERCUSIÓN LUMBAR NEGATIVA

Piel y faneras:

SIN LESIONES

Genito-Urinario:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

No revisado

Extremidades:

SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, NO EDEMA, CON PULSOS DISTALES CONSERVADOS

Sistema nervioso central:

GLASGOW 15/15, NO SIGNOS MENÍNGEOS APARENTES, NO ALTERACIONES MOTORAS O SENSITIVAS

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA NOVENA DÉCADA DE LA VIDA, QUIEN INGRESA TRAÍDA POR FAMILIARES, REFIEREN CUADRO CLÍNICO DE APROXIMADAMENTE 4 DÍAS DE EVOLUCIÓN, CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS, ASOCIADO A SENSACIÓN DE MALESTAR GENERAL, AL INTERROGATORIO PACIENTE REFIERE CUADRO DE TOS SECA Y POLAQUIURIA/ORINA FÉTIDA DE APROX 10 DÍAS DE EVOLUCIÓN, A SU INGRESO SE HALLA EN REGULAR ESTADO GENERAL, FEBRIL (38.5°C) SIN EMBARGO TOLERANDO VO Y OXÍGENO AMBIENTE, AL EXAMEN FÍSICO, CON LEVE DOLOR A LA PALPACIÓN DE HIPOGASTRIO, SE DECIDE INGRESAR COMO FIEBRE EN ESTUDIO, SE INICIA MANEJO CON LEV, ANTIPIRÉTICOS IV Y SOLICITAN ESTUDIOS PARACLÍNICOS, SE REVALORARÁ CON RESULTADOS.

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:**Diagnóstico Principal:** R104 : OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS**Diagnóstico Relacionado 1:** A689 : FIEBRE RECURRENTE, NO ESPECIFICADA**EVOLUCIONES:**

Fecha: 19/09/2024: 21:36:03, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: FRANCIELENA MACIA CARABALLO, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: EVOLUCION MEDICINA GENERAL

Descripción: PACIENTE DE MENINA DE 84 AÑOS CON ANTECEDENTES DE ARTRITIS REUMATOIDE (NO REFIERE MANEJO, MAL INFORMANTE, EN EL MOMENTO SIN FAMILIAR) QUIEN INGRESA POR CUADRO CLÍNICO DE APROXIMADAMENTE 4 DÍAS DE EVOLUCIÓN, CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS, ASOCIADO A SENSACIÓN DE MALESTAR GENERAL, AL INTERROGATORIO PACIENTE REFIERE CUADRO DE TOS SECA Y POLAQUIURIA/ORINA FÉTIDA DE APROX 10 DÍAS DE EVOLUCIÓN, A SU INGRESO SE HALLA EN REGULAR ESTADO GENERAL, FEBRIL (38.5°C), CON LEVE DOLOR A LA PALPACIÓN DE HIPOGASTRIO. SE TOMAN PARACLÍNICOS CON CUADRO HEMÁTICO CON LEUCOCITOSIS DE 18.570 A EXPENSAS DE NEUTROFILOS, SIN ANEMIA, SIN TROMBOCITOPENIA, REACTANTES DE FASE AGUDA ELEVADOS, CON HIPERBILIRRUBINEMIA A EXPENSAS DE LA DIRECTA, AZOADOS DENTRO DE LÍMITES DE NORMALIDAD, HIPONATREMIA LEVE, SIN OTRAS SINTOMATOLOGÍAS ADICIONALES; REPORTE DE RADIOGRAFÍA DE TÓRAX CON EVIDENCIA DE OPACIDADES EN "VÍDRIO ESMERILADO" A LO LARGO DE AMBOS HEMITÓRAX CON TENDENCIA A LA CONSOLIDACIÓN EN LA BASE PULMONAR DERECHA, CON IMAGEN RADIOLÚCIDA DE PARED GRUESA REDONDEADA BIEN DEFINIDA, CON DIÁMETRO MAYOR DE 34 MM EN EL ÁPICE PULMONAR DERECHO Y CRECIMIENTO VENTRICULAR IZQUIERDO. AORTA Densa Y ELONGADA. DILATACIÓN ANEURISMÁTICA DEL CAYADO?. EN EL MOMENTO PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN PRESENCIA DE NUEVOS PICOS FEBRILES, AL EXAMEN FÍSICO CON PRESENCIA DE CRIPITOS EN TODOS LOS CAMPOS PULMONARES DERECHOS. TENIENDO EN CUENTA LA PRESENCIA DE CUADRO DE POSIBLE SEPSIS DE ORIGEN PULMONAR SECUNDARIA A NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD SE CONSIDERA SOLICITAR ESTUDIOS ADICIONALES Y VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA. SE EXPLICA AMPLIAMENTE PLAN DE MANEJO A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. PLAN OBSERVACIÓN DIETA A TOLERANCIA LACTATO RINGER A RAZÓN DE 60 CC/H PARACETAMOL 1 GR IV CADA 8 HORAS. ISONIAZIDA 200 MG IV CADA 8 HORAS. SS/ GASES ARTERIALES, ECOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL. SS/ VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA. CSV Y AC

Fecha: 20/09/2024: 12:03:05, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: KAREN ELENA MARSIGLIA IBAÑEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Neumonía adquirida en la comunidad CURB 65: 1 punto, PSI clase III riesgo bajo.

2. Sintomático respiratorio:

2.1 Tuberculosis pulmonar a descartar.

3. Exacerbación de la enfermedad

4. Artritis reumatoide

5. Fibrilación auricular por HC

6. Padua score 5 puntos

Subjetivo:

Paciente refiere haber pasado buena noche

Objetivo:

PA 120/70 mmHg, FC 76 lpm, FR 27 rpm, T 36.1°C, SpO2 99% a aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula asistida.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Ojos con secreciones versidad bilateral, esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante pániculo adiposo, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, ausencia de vello

Alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

20/09/2024

LEU 18.57 NEU 71.2%(13.22) LINF 12.9%(2.40) MONO 11.3%(2.09) EOS 0.24%(0.04) BAS 4.39%(0.82) ERITROCITOS 3.86 HBO 12.2 HTO 34.8

VCM 90.3

HCM 31.5 pg

CCMH 34.9

IDE 15.9

PLT 341

PCR 21.0 mg/dL

BUN 14 mg/dl

CREA 0.79 mg/dl

SODIO EN SUERO 131 mmol/L

CLORO EN SANGRE 97 mmol/L

POTASIO EN SUERO 3.8 mmol/L

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

GLUCOSA EN SUERO 86 mg/dl

Bilirrubina Total 2.61
Bilirrubina Directa 1.54
Bilirrubina Indirecta 1.07

PH 7.391 7.350 7.450
PCO2 26.0 mmHg 35.0 45.0
PO2 89.4 mmHg 75.0 100.0
HCO3-act 15.4 mmol/L
HCO3-std 17.3 mmol/L
BE(B) -8.7 mmol/L
BE(ecf) -9.5 mmol/L
ctCO2 16.2 mmol/L
CO - OXIMETRIA
Hct 19 %
tHb 6.4 g/dL 2.0 25.0
sO2 97.7 %
FO2Hb 96.1 % 0.0 100.0
FCOHb 1.3 % 0.0 100.0
FMetHb 0.3 % 0.0 100.0
FHHb 2.3 % 0.0 100.0
EST. OXIGENACIÓN
pO2 /FIO2 4.26 mmHg/%
CORREGIDOS
PH(T). 7.401 T
PCO2(T) 25.2 mmHg
PO2(T) 85.5 mmHg
METABOLITOS
GLU 60 mg/dL 80 120
Lac 2.26 mmol\134134L
Temperatura: 36.3 °C
FIO2 21.0 %
Bilirrubina <2.0
AnGap 15.1 mmol\134134L

Radiografía de tórax

RADIOGRAFIA DE TORAX:

Opacidades en "vidrio esmerilado" a lo largo de ambos hemitórax con tendencia a la consolidación en la base pulmonar derecha.

Imagen radiolúcida de pared gruesa redondeada bien definida, con diámetro mayor de 34 mm en el ápice pulmonar derecho.

Tractos atelectásicos en el ápice pulmonar derecho y las bases pulmonares.

Ángulos costodiafragmáticos libres.

Crecimiento ventricular izquierdo. Aorta densa y elongada. Dilatación aneurismática del cayado?.

Prominencia del hilio pulmonar izquierdo.

Cambios óseos degenerativos.

Osteopenia generalizada.

Análisis:

Femenina de 84 años de edad con antecedentes de artritis reumatoide no adherente a tratamiento y fibrilación auricular por HC. Quien ingresa por síntomas respiratorios y fiebre. Actualmente estable hemodinamicamente, qSOFA 1 punto, NEWS 3 puntos, con agregados pulmonares. Al interrogatorio con hija Erica Martínez refiere que sintomatología obstructiva es de un mes de evolución y que los picos febriles tuvieron inicio el día domingo, por lo que cumple con criterios de sintomático respiratorio y se da orden de hospitalización con aislamiento. Radiografía de tórax en la cual se visualizan opacidades en vidrio esmerilado en ambos hemitórax, caverna el lóbulo superior izquierdo sin cambios con respecto a radiografía de hace 2 años. Paciente quien debe permanecer hospitalizada bajo terapia antibiótica y a la espera de realización de paraclínicos de extensión y resultados de baciloscopías seriadas. Se explica a paciente y familiar quienes refieren entender y aceptar.

Fecha: 21/09/2024: 11:36:02, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: DIEGO MORENO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Neumonía adquirida en la comunidad CURB 65: 1 punto, PSI clase III riesgo bajo.

2. Sintomático respiratorio:

2.1 Tuberculosis pulmonar

3. Estabaquista pesada

4. Artritis reumatoide

5. Fibrilación auricular por HC

6. Padua score 5 puntos

Subjetivo:

Paciente refiere que pasó buena noche, niega nuevos picos febriles, niega dificultad respiratorio.

Objetivo:

PA 110/80 mmHg, FC 76 lpm, FR 36 rpm, T 36.1°C, SpO2 99% a aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula asistida.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Ojos con secreciones versidad bilateral, esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante panículo adiposo, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, ausencia de vello

Alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

Análisis:

Femenina de 84 años de edad con antecedentes de artritis reumatoide no adherente a tratamiento y fibrilación auricular por HC hospitalizada en contexto de paciente sintomática respiratoria. Se valora paciente normotensa, normosaturando a aire ambiente, sin taquicardia, sin fiebre, sin dolor, a la auscultación con con agregados pulmonares bibasales. Cuenta con radiografía de tórax en la cual se visualizan opacidades en vidrio esmerilado en ambos hemitórax, caverna el lóbulo superior izquierdo sin cambios con respecto a radiografía de hace 2 años, por lo cual se realiza tomografía de tórax con visualización de amplia cavitación en lóbulo pulmonar derecho más abundantes infiltrados en ambos campos pulmonares por lo cual se considera que paciente cumple criterios clínicos y radiológicos para tuberculosis pulmonar y se inicia terapia RIPE, paciente sin antecedentes referidos de VIH por lo cual se solicita prueba de VIH, se solicitan pruebas de función hepática para evaluar seguridad de terapia RIPE y nuevos gases arteriales dado taquipnea. Paciente quien debe permanecer hospitalizada bajo terapia antibiótica previamente instaurada, pendiente resto de baciloscopias seriadas. Se explica a paciente y familiar quienes refieren entender y aceptar.

Fecha: 22/09/2024: 13:23:17, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: KAREN ELENA MARSIGLIA IBAÑEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Neumonía adquirida en la comunidad CURB 65: 1 punto, PSI clase III riesgo bajo.

2. Sintomático respiratorio:

2.1 Tuberculosis pulmonar

3. Extaquista pesada

4. Artritis reumatoide

5. Fibrilación auricular por HC

6. Padua score 5 puntos

Subjetivo:

Paciente refiere que dificultad respiratoria

Objetivo:

PA 120/75 mmHg, FC 79 lpm, FR 28 rpm, T 36°C, SpO2 91% a aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, buen estado musculoesquelético.

Piel normocrómica, sin lesiones. esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales de predominio derecho, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante panículo adiposo, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, Alerta, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS

22/09/2024

GASES ARTERIALES: PH 7.433, PCO2 34.0, PO2 66.9, HCO3 22.2, BE -1.4, PO2/FIO2 3.19, LAC 2.84 FIO2 21%, AnGap 13.5.

21/09/2024

VIH Ag/Ab: 0.11 (NEGATIVO)

fosfatasa alcalina : 100, AST 23, ALT 13

20/09/2024

BACILOSCOPIA: NO SE OBSERVAN BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

19/09/2024

HEMOGRAMA: LEU 18.57, NEU 13.22, ERITROCITOS 3.86, HB 12.2, HTO 34.8, VCM 90.3, HCM 31.5, PLT 341

VSG 36, PCR 21

BUN 14, CREA 0.79

BT 2.61, BD 1.54, BI 1.07

CL 97, K 3.8, NA 131,

GLUCOSA 86

GASES ARTERIALES: PH 7.391, PCO2 26.0, PO2 89.4, HCO3 15.4, PIO2 /FIO2 4.26, LAC 2.26, FIO2 21.0, AnGap 15.1

IMAGENES

20/09/2024

ECOGRAFÍA ABDOMINAL TOTAL:

El Hígado es de forma, tamaño y ecogenicidad normales, sin lesiones focales o difusas

La Vesícula biliar se encuentra ausente por antecedente quirúrgico previo

La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.

El Páncreas, los Riñones y el Bazo son de tamaño, forma y ecogenicidad normales

Los grandes vasos y estructuras retroperitoneales no presentan alteraciones.

La vejiga es de paredes regulares y no se evidencian ecos en su interior.

No hay evidencia de líquido libre dentro de la cavidad abdominal.

CONCLUSION

Estado post-colecistectomía

19/09/2024

RADIOGRAFÍA DE TORAX

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

Opacidades en "vidrio esmerilado" a lo largo de ambos hemitórax con tendencia a la consolidación en la base pulmonar derecha. Imagen radiolúcida de pared gruesa redondeada bien definida, con diámetro mayor de 34 mm en el ápice pulmonar derecho. Tractos atelectásicos en el ápice pulmonar derecho y las bases pulmonares. Ángulos costodiafragmáticos libres. Crecimiento ventricular izquierdo. Aorta densa y elongada. Dilatación aneurismática del cayado?. Prominencia del hilio pulmonar izquierdo. Cambios óseos degenerativos. Osteopenia generalizada

Análisis:
Paciente femenina de 84 años de edad con antecedentes de artritis reumatoide no adherente a tratamiento y fibrilación auricular por HC hospitalizada en contexto de paciente sintomática respiratoria. A la valoración eucárdica, taquipneica, saturando en el límite inferior a aire ambiente, con regular patrón respiratorio. A la auscultación pulmonar con crepitos bibasales de predominio derecho. Cuenta con paraclínicos de ingresos que evidencian hemograma con leucocitosis a expensas de neutrofilia sin alteración en las demás líneas celulares, reactantes de fase aguda elevados, función renal normal, bilirrubinas elevadas, glucosa normal, transaminasas normales, fosfatasa alcalina normal, VIH negativo, y baciloscopia #1 negativa. Dada la dificultad respiratoria se decide realizar gases arteriales el día de hoy, los cuales evidencian hipoxemia leve, por lo cual se indicó oxígeno suplementario por cánula nasal. Cuenta con radiografía de tórax en la cual se visualizan opacidades en vidrio esmerilado en ambos hemitórax, caverna el lóbulo superior izquierdo. por lo cual se realiza tomografía de tórax con visualización de amplia cavitación en lóbulo pulmonar derecho más abundantes infiltrados en ambos campos pulmonares por lo cual se considera que paciente cumple criterios clínicos y radiológicos para tuberculosis pulmonar y se inicia terapia RIPE. Continuamos con igual manejo médico instaurado, es escalona antibioticoterapia dado que presentan alto del parénquima pulmonar, lo cual constituye un riesgo para psudomonas y se añade manejo con broncodilatador. Se solicitan paraclínicos de control, pendiente pcr y cultivo mycobacterium tuberculosis Se explica a paciente y familiar quienes refieren entender y aceptar.

Fecha: 23/09/2024: 16:04:53, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratoria
- 1.1 Tuberculosis pulmonar a descartar
2. EPOC exacerbado Anthonisen III
- 2.1. Exabaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico
4. Artritis reumatoide en manejo

Subjetivo:

Paciente refiere dificultad respiratoria

Objetivo:

PA 130/60 mmHg, FC 71 lpm, FR 24 rpm, T 36°C, SpO2 97% a aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, buen estado musculoesquelético.

Piel normocrómica, sin lesiones. esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales de predominio derecho, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante pániculo adiposo, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, Alerta, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS

22/09/2024

HEMOGRAMA: LEU 14.72, NEU 10.05, EITROCITOS 3.63, HB 11.4, HTO 32.9, VCM90.7, HCM31.4, PLT 404

BUN 9, CREA 0.75

BT 1.04, BD 0.70, BI 0.34

PCR 12.2

GASES ARTERIALES: PH 7.433, PCO2 34.0, PO2 66.9, HCO3 22.2, BE -1.4, PO2/FIO2 3.19, LAC 2.84/FIO2 21%, AnGap 13.5.

21/09/2024

VIH Ag/Ab: 0.11 (NEGATIVO)

fosfatasa alcalina : 100, AST 23, ALT 13

20/09/2024

BACILOSCOPIA: NO SE OBSERVAN BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

19/09/2024

HEMOGRAMA: LEU 18.57, NEU 13.22, EITROCITOS 3.86, HB 12.2, HTO 34.8, VCM90.3, HCM31.5, PLT 341

VSG 36, PCR 21

BUN 14, CREA 0.79

BT 2.61, BD 1.54, BI 1.07

CL 97, K 3.8, NA 131,

GLUCOSA 86

GASES ARTERIALES: PH 7.391, PCO2 26.0, PO2 89.4, HCO3 15.4, PIO2 /FIO2 4.26, LAC 2.26, FIO2 21.0, AnGap 15.1

IMAGENES

20/09/2024

ECOGRAFÍA ABDOMINAL TOTAL:

El Hígado es de forma, tamaño y ecogenicidad normales, sin lesiones focales o difusas

La Vesícula biliar se encuentra ausente por antecedente quirúrgico previo

La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

El Páncreas, los Riñones y el Bazo son de tamaño, forma y ecogenicidad normales
 Los grandes vasos y estructuras retroperitoneales no presentan alteraciones.
 La vejiga es de paredes regulares y no se evidencian ecos en su interior.
 No hay evidencia de líquido libre dentro de la cavidad abdominal.
CONCLUSION
 Estado post-colecistectomía

19/09/2024

RADIOGRAFÍA DE TORAX

Opacidades en "vidrio esmerilado" a lo largo de ambos hemitórax con tendencia a la consolidación en la base pulmonar derecha.
 Imagen radiolúcida de pared gruesa redondeada bien definida, con diámetro mayor de 34 mm en el ápice pulmonar derecho.
 Tractos atelectásicos en el ápice pulmonar derecho y las bases pulmonares.
 Ángulos costodiafragmáticos libres.
 Crecimiento ventricular izquierdo. Aorta densa y elongada. Dilatación aneurismática del cayado?
 Prominencia del hilio pulmonar izquierdo.
 Cambios óseos degenerativos.
 Osteopenia generalizada

Análisis:

Paciente femenina de 84 años de edad con antecedentes de estibaquismo, artritis reumatoide con reinicio de manejo con metotrexate desde abril 2024. Hospitalizada en contexto de síntomas respiratorios crónicos y disnea. tiene radiografía de tórax en la cual se visualizan opacidades infiltrados intersticiales bibasales en ambos hemitórax, caverna en el lóbulo superior izquierdo por lo cual se realizó tomografía de tórax con visualización de amplia cavitación en lóbulo pulmonar derecho más abundantes infiltrados en ambos campos pulmonares por lo cual se considera que paciente cumple criterios clínicos y radiológicos para tuberculosis pulmonar y se inició terapia RIPE. Pendiente PCR para tuberculosis, ya tomada. Además antibióticoterapia por posibilidad de EPOC exacerbado.

A la valoración eucárdica, taquipneica, saturando adecuadamente con aire ambiente, afebril, resto de signos vitales normales, diuresis conservada. A la auscultación pulmonar con crepitos bibasales de predominio derecho. Cuenta con paracrónicos de control que evidencian leucocitosis a expensas de neutrofilia en descenso en comparación con los paracrónicos de ingreso, función renal conservada, bilirrubinas normales, pcr elevada pero que bien en descenso en comparación con la de ingreso y gases arteriales los cuales evidencian hipoxemia leve, e hiperlactatemia ligera.
 Además tiene reporte de VIH negativo, y baciloscopia #1 negativa.

Llama la atención que desde 2022 tiene hallazgos radiográficos muy similares, sin antecedentes previos de manejo para tuberculosis, además refiere PPD de abril negativa. Se solicitan baciloscopias restantes #2 y #3 y valoración por infectología para consideración de diagnósticos diferenciales.

Continúo resto de manejo médico. Se explica a paciente y familiar quienes refieren entender y aceptar.

Fecha: 24/09/2024: 12:43:51, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** MELKIS ANTONIO BUELVAS VILLALBA, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratoria
- 1.1 Tuberculosis pulmonar a descartar
2. EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado
- 2.1. Estibaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico
4. Artritis reumatoide en manejo
5. Obesidad

Subjetivo:

Paciente refiere mejoría de la tos

Objetivo:

PA 130/90 mmHg, FC 95 lpm, FR 24 rpm, T 36°C, SpO2 94 % a aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, buen estado musculoesquelético.

Piel normocrómica, sin lesiones. esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpandible, no tirajes, con crepitos bibasales de predominio derecho, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante pánicula adiposo, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, Alerta, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléjico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS

23/09/2024

Baciloscopia #2: No se observan BAAR en 100 campos analizados

22/09/2024

HEMOGRAMA: LEU 14.72, NEU 10.05, ERITROCITOS 3.63, HB 11.4, HTO 32.9, VCM90.7, HCM31.4, PLT 404

BUN 9, CREA 0.75

BT 1.04, BD 0.70, BI 0.34

PCR 12.2

GASES ARTERIALES: PH 7.433, PCO2 34.0, PO2 66.9, HCO3 22.2, BE -1.4, PO2/FIO2 3.19, LAC 2.84FIO2 21%, AnGap 13.5.

21/09/2024

VIH Ag/Ab: 0.11 (NEGATIVO)

fosfatasa alcalina : 100, AST 23, ALT 13

20/09/2024

BACILOSCOPIA: NO SE OBSERVAN BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

19/09/2024

HEMOGRAMA: LEU 18.57, NEU 13.22, ERITROCITOS 3.86, HB 12.2, HTO 34.8, VCM90.3, HCM31.5, PLT 341
VSG 36, PCR 21
BUN 14, CREA 0.79
BT 2.61, BD 1.54, BI 1.07
CL 97, K 3.8, NA 131,
GLUCOSA 86
GASES ARTERIALES: PH 7.391, PCO2 26.0, PO2 89.4, HCO3 15.4, PIO2 /FIO2 4.26, LAC 2.26, FIO2 21.0, AnGap 15.1

IMAGENES

20/09/2024

ECOGRAFÍA ABDOMINAL TOTAL:

El Hígado es de forma, tamaño y ecogenicidad normales, sin lesiones focales o difusas
La Vesícula biliar se encuentra ausente por antecedente quirúrgico previo
La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.
El Páncreas, los Riñones y el Bazo son de tamaño, forma y ecogenicidad normales
Los grandes vasos y estructuras retroperitoneales no presentan alteraciones.
La vejiga es de paredes regulares y no se evidencian ecos en su interior.
No hay evidencia de líquido libre dentro de la cavidad abdominal.

CONCLUSION

Estado post-colecistectomía

19/09/2024

RADIOGRAFÍA DE TORAX

Opacidades en "vidrio esmerilado" a lo largo de ambos hemitórax con tendencia a la consolidación en la base pulmonar derecha.
Imagen radiolúcida de pared gruesa redondeada bien definida, con diámetro mayor de 34 mm en el ápice pulmonar derecho.
Tractos atelectásicos en el ápice pulmonar derecho y las bases pulmonares.
Ángulos costodiafragmáticos libres.
Crecimiento ventricular izquierdo. Aorta densa y elongada. Dilatación aneurismática del cayado?
P prominencia del hilio pulmonar izquierdo.
Cambios óseos degenerativos.
Osteopenia generalizada

Análisis:

Paciente femenina de 84 años de edad con antecedentes de estibaquismo, artritis reumatoide con reinicio de manejo con metotrexate desde abril 2024.
Hospitalizada en contexto de síntomas respiratorios crónicos y disnea. tiene radiografía de tórax en la cual se visualizan infiltrados intersticiales bibasales en ambos hemitórax, lesión cavitada en el lóbulo superior derecho por lo cual se realizó tomografía de tórax con visualización de amplia cavitación en lóbulo pulmonar derecho más abundantes infiltrados en ambos campos pulmonares y áreas de enfisema bilateral. Dado los hallazgos anteriores se consideró que la paciente cumplía criterios clínicos y radiológicos para tuberculosis pulmonar y se inició terapia RIPE hasta ahora las 2 primeras baciloscopias han sido negativas. Pendiente PCR para tuberculosis, ya tomada. Además, recibe antibioterapia por posibilidad de EPOC exacerbado - sobreinfectado.

Llama la atención que desde 2022 tiene hallazgos radiográficos muy similares, sin antecedentes previos de manejo para tuberculosis, además refiere PPD de abril negativa. Pendiente valoración por infectología para consideración de diagnósticos diferenciales.

A la valoración eucárdica, taquipneica, saturando adecuadamente con aire ambiente, afebril, resto de signos vitales normales, diuresis conservada. A la auscultación pulmonar con crepitos bibasales de predominio derecho. Cuenta con parámetros de control que evidencian leucocitosis a expensas de neutrofilia en descenso en comparación con los parámetros de ingreso, función renal conservada, bilirrubinas normales, pcr elevada pero que bien en descenso en comparación con la de ingreso y gases arteriales los cuales evidencian hipoxemia leve, e hiperlactatemia ligera.
Además tiene reporte de VIH negativo, y baciloscopia #1 y #2 negativa.

Continúa resto de manejo médico a la espera de certeza diagnóstica y toma de nuevas conductas. Se explica a paciente y familiar quienes refieren entender y aceptar.

Fecha: 25/09/2024: 10:12:32, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar a descartar
2. Sospecha de EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado
- 2.1. Ex Tabaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico
4. Artritis reumatoide en manejo
5. Obesidad

Subjetivo:

: Paciente refiere haber pasado buena noche.

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

PA 125/75 mmHg, FC 73 lpm, FR 27 rpm, T 36.1°C, SpO2 99% a aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59
Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula asistida.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Ojos con secreciones versidad bilateral, esclera anictérica, isocoría normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante pánicula adiposa, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, ausencia de vello

Alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

23/09/2024

BASIOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE

ESPUTO

2 MUESTRAS

NO SE OBSERVA BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

22/09/2024

HEMOGRAMA

LEUCOCITOS 14.72

NEUTROFILOS% 68.3

NEUTROFILOS# 10.05

LINFOCITOS% 16.6

LINFOCITOS# 2.44

MONOCITOS% 10.3

MONOCITOS# 1.51

EOSINOFILOS% 3.08

EOSINOFILOS# 0.45

BASOFILOS% 1.81

BASOFILOS# 0.27

LUC (Lif. Reactivos, Celulas Grandes no

ERITROCITOS 3.63

HEMOGLOBINA 11.4

HEMATOCRITO 32.9

INDICES HEMATICOS

Volumen Corpuscular Medio (VCM): 90.7

Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): 31.4

Concentracion Hb. Corp. Media (CCMH): 34.6

Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 16.1

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas (PLT): 404

Volumen Plaquetario Medio (VPM): 4.92

Plaquetocrito (PTC): 0.20

Ancho Distrib. de Plaq.(PDW): 17.21

BILIRRUBINA

BT 1.04

BD 0.70

BI 0.34

CREATININA 0.75

NITROGENO 9

PCR 12.2

GASES ARTERIALES

PH.....: 7.433

PCO2 34.0

PO2 66.9

HCO3-act 22.2

HCO3-std 23.2

BE(B) -1.4

BE(ecf) -2.1

ctCO2 23.3

CO - OXIMETRIA

Hct 36

thb 12.4

sO2 94.2

FO2Hb 93.2

FCOHb 1.0

FMethb 0.1

FHHb 5.7

O2SAT(EST)

EST. OXIGENACION

pO2 /FIO2 3.19

CORREGIDOS

PH(T).....: 7.448

PCO2(T) 32.5

PO2(T) 62.5

PO2(A-a)(T)

PO2(a-A)(T)

RI(T)

METABOLITOS

GLU 139

Lac.....: 2.84

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

Temperatura.....: 36.0
 FIO2.....: 21.0
 Bilirrubina.....: <2.0
 AnGap.....: 13.5

21/09/2024
 VIH: 0.11
 TRANSAMINASA GLU 23
 TRANSAMINASA 13
 FOSFATASA ALCALINA 100

20/09/2024
 MYCOBACTERIUM TB: ESPUTO
 COMPLEJO: NO DETECTABLE
 RIFAMPICINA: N/A
 ISONIAZIDA N/A
 TECNICA: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX ANYPLEX II MTB/ MDR

BASILOSCOPIA
 ESPUTO
 MUCUOPURULENTA
 REPORTE: NO SE OBSERVA BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

19/09/2024

PCR 21.0
 ERITROSEDIMENTACION 36
 NITROGENO 14
 CREATININA 0.79
 SODIO 131
 CLORO 97
 POTASIO 3.8
 GLUCOSA 86
 BILIRRUBINAS
 BT 2.61
 BD 1.54
 BI 1.07

HEMOGRAMA
 LEUCOCITOS 18.57
 NEUTROFILOS% 71.2
 NEUTROFILOS# 13.22
 LINFOCITOS% 12.9
 LINFOCITOS# 2.40
 MONOCITOS% 11.3
 MONOCITOS# 2.09
 EOSINOFILOS% 0.24
 EOSINOFILOS# 0.04
 BASOFILOS% 4.39
 BASOFILOS# 0.82
 LUC (Lif. Reactivos, Celulas Grandes no

ERITROCITOS 3.86
 HEMOGLOBINA 12.2
 HEMATOCRITO 34.8

INDICES HEMATICOS
 Volumen Corpuscular Medio (VCM): 90.3
 Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): 31.5
 Concentracion Hb. Corp. Media (CCMH): 34.9
 Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 15.9

SERIE PLAQUETARIA
 Plaquetas (PLT): 341
 Volumen Plaquetario Medio (VPM): 5.17
 Análisis:

Femenina de 84 años con antecedentes de FA, tabaquismo pesado, y artritis reumatoide con tratamiento inadherente con metotrexate quien ingresa por picos febriles y tos con expectoración de 1 mes de duración. Hemograma de ingreso con leucocitosis marcada e hiperbilirrubinemia. Función renal conservada. Al examen físico se valora paciente hemodinámicamente estable con signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral. Debido al estado de inmunosupresión del paciente, cuadro respiratorio e imágenes sugestivas se sospechó infección por tuberculosis. Se solicitaron paraclínicos para su posterior estudio de cuadro con reporte de 2 baciloscopias negativas para BAAR y PCR para M. tuberculosis negativa, por lo que se considera realización de fibrobroncoscopia. Dado el antecedente de artritis reumatoide se solicitó valoración por servicio de neumología para evaluar posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial asociado a patología inmune, a la espera de concepto. Se mantiene hospitalizada bajo manejo antibiótico por posible EPOC exacerbado con sobreinfección bacteriana. Se continúa con terapia RIPE. a espera de valoración, Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 26/09/2024: 11:10:26, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

P: 1. Sintomático respiratoria

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

- 1.1 Tuberculosis pulmonar a descartar
2. EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado
- 2.1. Ex Tabaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico
4. Artritis reumatoide en manejo
5. Obesidad

Subjetivo:

Refiere buena noche, buen patrón de sueño, sin síntomas de importancia

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

PA 125/75 mmHg, FC 73 lpm, FR 27 rpm, T 36.1°C, SpO2 99% aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula asistida.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Ojos con secreciones versidad bilateral, esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante pánicula adiposa, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, ausencia de vello

Alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

23/09/2024

BASIOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE

ESPUTO

2 MUESTRAS

NO SE OBSERVA BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

22/09/2024

HEMOGRAMA

LEUCOCITOS 14.72

NEUTROFILOS% 68.3

NEUTROFILOS# 10.05

LINFOCITOS% 16.6

LINFOCITOS# 2.44

MONOCITOS% 10.3

MONOCITOS# 1.51

EOSINOFILOS% 3.08

EOSINOFILOS# 0.45

BASOFILOS% 1.81

BASOFILOS# 0.27

LUC (Lif. Reactivos, Celulas Grandes no

ERITROCITOS 3.63

HEMOGLOBINA 11.4

HEMATOCRITO 32.9

INDICES HEMATICOS

Volumen Corpuscular Medio (VCM): 90.7

Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): 31.4

Concentración Hb.Corp.Medía (CCMH): 34.6

Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 16.1

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas (PLT): 404

Volumen Plaquetario Medio (VPM): 4.92

Plaquetocrito (PTC): 0.20

Ancho Distrib. de Plaq.(PDW): 17.21

BILIRRUBINA

BT 1.04

BD 0.70

BI 0.34

CREATININA 0.75

NITROGENO 9

PCR 12.2

GASES ARTERIALES

PH.....: 7.433

PCO2 34.0

PO2 66.9

HCO3-act 22.2

HCO3-std 23.2

BE(B) -1.4

BE(ecf) -2.1

ctCO2 23.3

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

CO - OXIMETRIA
Hct 36
thb 12.4
sO2 94.2
FO2Hb 93.2
FCOHb 1.0
FMetHb 0.1
FHHb 5.7
O2SAT(EST)
EST. OXIGENACION
pO2 /FIO2 3.19
CORREGIDOS
PH(T).....: 7.448
PCO2(T) 32.5
PO2(T) 62.5
PO2(A-a)(T)
PO2(a-A)(T)
RI(T)
METABOLITOS
GLU 139
Lac.....: 2.84
Temperatura.....: 36.0
FIO2.....: 21.0
Bilirrubina.....: <2.0
AnGap.....: 13.5

21/09/2024
VIH: 0.11
TRANSAMINASA GLU 23
TRANSAMINASA 13
FOSFATASA ALCALINA 100

20/09/2024
MYCOBACTERIUM TB: ESPUTO
COMPLEJO: NO DETECTABLE
RIFAMPICINA: N/A
ISONIAZIDA N/A
TECNICA: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX ANYPLEX II MTB/ MDR

BASILOSCOPIA
ESPUTO
MUCUOPURULENTO
REPORTE: NO SE OBSERVA BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

19/09/2024

PCR 21.0
ERITROSEDIMENTACION 36
NITROGENO 14
CREATININA 0.79
SODIO 131
CLORO 97
POTASIO 3.8
GLUCOSA 86
BILIRRUBINAS
BT 2.61
BD 1.54
BI 1.07

HEMOGRAMA
LEUCOCITOS 18.57
NEUTROFILOS% 71.2
NEUTROFILOS# 13.22
LINFOCITOS% 12.9
LINFOCITOS# 2.40
MONOCITOS% 11.3
MONOCITOS# 2.09
EOSINOFILOS% 0.24
EOSINOFILOS# 0.04
BASOFILOS% 4.39
BASOFILOS# 0.82
LUC (Lif. Reactivos, Celulas Grandes no

ERITROCITOS 3.86
HEMOGLOBINA 12.2
HEMATOCRITO 34.8

INDICES HEMATICOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

Volumen Corpuscular Medio (VCM): 90.3
Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): 31.5
Concentración Hb. Corp. Media (CCMH): 34.9
Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 15.9

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas (PLT): 341
Volumen Plaquetario Medio (VPM): 5.17

20/09/2024

ECOGRAFÍA ABDOMINAL TOTAL:

El Hígado es de forma, tamaño y ecogenicidad normales, sin lesiones focales o difusas.
La Vesícula biliar se encuentra ausente por antecedente quirúrgico pRevio.
La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.
El Páncreas, los Riñones y el Bazo son de tamaño, forma y ecogenicidad normales.
Los grandes vasos y estructuras retroperitoneales no presentan alteraciones.
La vejiga es de paredes regulares y no se evidencian ecos en su interior.
No hay evidencia de líquido libre dentro de la cavidad abdominal.

CONCLUSION

Estado post-colecistectomía

20/09/2024

TAC DE TÓRAX:

Se realiza estudio en equipo multidetector mediante cortes secuenciales axiales desde la entrada torácica hasta el nivel de los diafragmas. Se obtuvo registro con ventana para pulmón y mediastino.
El parénquima pulmonar presenta opacidades en vidrio deslustrado difusas bilaterales con presencia de formaciones quísticas subpleurales periféricas y hacia la base por neumopatía intersticial crónica. La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.
Engrosamiento pleural derecho.
La silueta cardíaca es de tamaño y configuración normales. Los grandes vasos son de calibre, disposición y apariencia usuales.
El calibre de la vía aérea desde la tráquea hasta los bronquios lobares y segmentarios es adecuado, no hay áreas de estrechez ni compresión extrínseca. El esófago es de paredes delgadas.
No hay evidencia de adenomegalias en las diferentes estaciones ganglionares.
La caja torácica no muestra alteraciones.

19/09/2024

RADIOGRAFÍA DE TORAX:

Opacidades en "vidrio esmerilado" a lo largo de ambos hemitórax con tendencia a la consolidación en la base pulmonar derecha.
Imagen radiolúcida de pared gruesa redondeada bien definida, con diámetro mayor de 34 mm en el ápice pulmonar derecho.
Tractus atelectásicos en el ápice pulmonar derecho y las bases pulmonares.
Ángulos costodiafragmáticos libres.
Crecimiento ventricular izquierdo. Aorta densa y elongada. Dilatación aneurismática del cayado?
P prominencia del hilio pulmonar izquierdo.
Cambios óseos degenerativos.
Osteopenia generalizada

25/09/2024

RESPUESTA DE INTERCONSULTA DE NEUMOLOGÍA

MAXIMA BELLO BATISTA

Identificación: 33146271

MOTIVO DE CONSULTA: Le está dando mucha fiebre?

ENFERMEDAD ACTUAL Y MOTIVO DE INTERCONSULTA: Paciente con antecedente de artritis reumatoide, en manejo farmacológico con metotrexato quien curso con cuadro clínico de 1 mes de evolución consistente en síntomas respiratorios y fiebre, imagen radiográfica con presencia de cavitaciones en lóbulo superior derecho que se confirman en tomografía de tórax, se compara con radiografía de tórax previa de 2022 donde también se evidenciaban dichas cavitaciones, se considera que dado el estado de inmunosupresión de la paciente, clínica y hallazgos imagenológicos tiene alta probabilidad de infección por tuberculosis pulmonar, por esto se indica continuar terapia riPE y dado presencia de leucocitosis con neutrofilia continuar antibióticoterapia por posible sobreinfección bacteriana, esperamos reporte de PCR para Mycobacterium y en caso que las baciloscopias sean negativas y la PCR también sea negativa se deberá solicitar fibrobroncoscopia por la alta probabilidad de tuberculosis en paciente inmunosuprimida.

Dado el antecedente de artritis reumatoide, se solicita valoración por neumología para evaluar posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial asociado a patología inmune.

23/09/2024

BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE ESPUTO 2 MUESTRAS
NO SE OBSERVABA EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

22/09/2024

HEMOGRAMA LEUCOCITOS 14.72 NEUTROFILOS% 68.3 NEUTROFILOS# 10.05
LINFOCITOS% 16.6 LINFOCITOS# 2.44 MONOCITOS% 10.3 MONOCITOS# 1.51

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

EOSINOFILOS% 3.08 EOSINOFILOS# 0.45 BASOFILOS% 1.81 BASOFILOS# 0.27 LUC
(Lif. Reactivos, Celulas Grandes no ERITROCITOS 3.63 HEMOGLOBINA 11.4
HEMATOCRITO 32.9 INDICES HEMATICOS Volumen Corpuscular Medio (VCM): 90.7
Hemoglobina Corpuscular Media(HCM): 31.4 Concentracion Hb.Corp.Med (CCMH): 34.6
Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 16.1 SERIE PLAQUETARIA Plaquetas (PLT): 404 Volumen
Plaquetario Medio (VPM): 4.92 Plaquetocrito (PTC): 0.20 Ancho Distrib. de Pla.(PDW):

17.21
BILIRRUBINA BT 1.04 BD 0.70 BI 0.34 CREATININA 0.75 NITROGENO 9 PCR 12.2
GASES ARTERIALES PH.: 7.433 PCO2 34.0 PO2 66.9 HCO3-act 22.2 HCO3-std 23.2
BE(B) -1.4 BE(ef) -2.1 ctCO2 23.3 CO- OXIMETRIA Hct 36 tHb 12.4 sO2 94.2 FO2Hb
93.2 FCOHb 1.0 FMetHb 0.1 FHHb 5.7 O2SAT(EST) EST. OXIGENACION pO2 /FIO2 3.19
CORREGIDOS PH(T): 7.448 PCO2(T) 32.5 PO2(T) 62.5 PO2(A-a)(T) PO2(a-a)(T) RI(T)
METABOLITOS GLU 139 Lac.: 2.84 Temperatura: 36.0 FIO2: 21.0 Bilirrubina: <2.0 AnGap:
13.5 21/09/2024 VH: 0.11 TRANSAMINASA GLU 23 TRANSAMINASA 13 FOSFATASA
ALCALINA 100

20/09/2024
MYCOBACTERIUM TB: ESPUTO COMPLEJO: NO DETECTABLE RIFAMPICINA: N/A
ISONIAZIDA N/A TECNICA: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX ANYPLEX II MTB/ MDR
BASIOSCOPIA ESPUTO MUCOPURULENTO REPORTE: NO SE OBSERVA BAAR EN
100 CAMPOS ANALIZADOS

19/09/2024
PCR 21.0 ERITROSEDIMENTACION 36 NITROGENO 14 CREATININA 0.79 SODIO 131
CLORO 97 POTASIO 3.8 GLUCOSA 86 BILIRRUBINAS BT 2.61 BD 1.54 BI 1.07
HEMOGRAMA LEUCOCITOS 18.57 NEUTROFILOS% 71.2 NEUTROFILOS# 13.22
LINFOCITOS% 12.9 LINFOCITOS# 2.40 MONOCITOS% 11.3 MONOCITOS# 2.09
EOSINOFILOS% 0.24 EOSINOFILOS# 0.04 BASOFILOS% 4.39 BASOFILOS# 0.82 LUC
(Lif. Reactivos, Celulas Grandes no ERITROCITOS 3.86 HEMOGLOBINA 12.2
HEMATOCRITO 34.8 INDICES HEMATICOS Volumen Corpuscular Medio (VCM): 90.3
Hemoglobina Corpuscular Media(HCM): 31.5 Concentracion Hb.Corp.Med (CCMH): 34.9
Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 15.9 SERIE PLAQUETARIA Plaquetas (PLT): 341 Volumen
Plaquetario Medio (VPM): 5.17

Análisis:
Femenino con antecedente de artritis reumatoide en manejo ambulatorio con metotexate
con mala adherencia a tratamiento, quien ingresa por cuadro clinico de 1 mes de evolucion
consistente en sintomas respiratorios y fiebre, con hallazgos imagenológicos en tomografia
de torax compatibles con patron probable de NIU. Paciente con baciloscopias seriadas y
PCR negativos por lo que se considera no cumple al momento con criterios para infeccion
pulmonar por TBC, ante hallazgo de cavitación y sintomatología infecciosa asociada debe
realizarse fibrobroncoscopia + LBA para descartar probable micosis
pulmonar e infecciones asociadas. Deben realizarse pruebas de función pulmonar asi como
TACAR una vez estabilizado en forma ambulatoria y valoración por neumología para definir
inicio de tratamiento antifibrotico.

DIAGNOSTICOS:

1. Enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a autoinmunidad
- 1.1 Artritis reumatoide seropositiva con compromiso pulmonar
2. Tuberculosis pulmonar a descartar
3. Sospecha de EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado
4. Obesidad

Plan:

Espirometria, DLCO, Volumen pulmonares.

25/09/24

VALORACION POR NEUMOLOGIA

Femenino con antecedente de artritis reumatoide en manejo ambulatorio con metotexate
con mala adherencia a tratamiento, quien ingresa por cuadro clinico de 1 mes de evolucion
consistente en sintomas respiratorios y fiebre, con hallazgos imagenológicos en tomografia
de torax compatibles con patron probable de NIU. Paciente con baciloscopias seriadas y
PCR negativos por lo que se considera no cumple al momento con criterios para infeccion
pulmonar por TBC, ante hallazgo de cavitación y sintomatología infecciosa asociada debe
realizarse fibrobroncoscopia + LBA para descartar probable micosis
pulmonar e infecciones asociadas. Deben realizarse pruebas de función pulmonar asi como
TACAR una vez estabilizado en forma ambulatoria y valoración por neumología para definir
inicio de tratamiento antifibrotico.

DIAGNOSTICOS:

1. Enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a autoinmunidad
- 1.1 Artritis reumatoide seropositiva con compromiso pulmonar
2. Tuberculosis pulmonar a descartar
3. Sospecha de EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado
4. Obesidad

Plan:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

Espirometría, DLCO, Volúmenes pulmonares.

24/09/2024

VALORACION POR INFECTOLOGIA

Impresiones diagnosticas

1. Sintomático respiratoria

1.1 Tuberculosis pulmonar a descartar

2. EPOC exacerbado Anthonisen III

2.1. Extabaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico

4. Artritis reumatoide en manejo

Tratamiento actual:

Piperacilina tazobactam 4,5 gramos IV cada 6 horas :.....FI: 22/09/2024:..... D2/7

TERAPIA RIPE: Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg + Pirazinamida 400 mg + Etambutol 275 mg tableta, administrar 4 tabletas VO cada día por 56 dosis

Piridoxina tableta 50 mg, dar 1 tab VO cada día

MOTIVO DE CONSULTA: ¿Le está dando mucha fiebre?

ENFERMEDAD ACTUAL:

Femenina de 84 años quien refiere cuadro clínico de aproximadamente 1 mes de evolución consistente en un pico febril acompañado de tos húmeda productiva con esputo verdoso quien recibió tratamiento antibiótico, desconoce nombre de mejoría parcial, persistencia de tos productiva y en las últimas 72 horas nuevamente inician picos febriles no cuantificados asociado de incremento de tos con expectoración amarillo-verdosa y disnea por lo que consulta hoy. Adicionalmente refiere coluria, niega síntomas irritativos urinarios. Niega hemoptisis, niega diaforesis nocturna, niega pérdida de peso, niega cefalea, niega otros síntomas asociados.

Análisis

Paciente con antecedente de artritis reumatoide, en manejo farmacológico con metotrexato quien curso con cuadro clínico de 1 mes de evolución consistente en síntomas respiratorios y fiebre, imagen radiográfica con presencia de cavitaciones en lóbulo superior derecho que se confirman en tomografía de tórax, se compara con radiografía de tórax previa de 2022 donde también se evidenciaban dichas cavitaciones, se considera que dado el estado de inmunosupresión de la paciente, clínica y hallazgos imagenológicos tiene alta probabilidad de infección por tuberculosis pulmonar, por esto se indica continuar terapia RIPE y dado presencia de leucocitosis con neutrofilia continuar antibioticoterapia por posible sobreinfección bacteriana, esperamos reporte de PCR para Mycobacterium y en caso que las baciloscopías sean negativas y la PCR también sea negativa se deberá solicitar fibrobroncoscopia por la alta probabilidad de tuberculosis en paciente inmunosuprimida.

Dado el antecedente de artritis reumatoide, se solicita valoración por neumología para evaluar posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial asociado a patología inmune. Se cierra interconsulta, quedamos atentos a nuevos llamados.

Plan

continuar terapia RIPE

pendiente reporte de última baciloscopia y PCR para Mycobacterium

valoración por neumología

se cierra interconsulta

quedamos atentos a nuevos llamados

Análisis:

Femenina de 84 años con antecedentes de FA, tabaquismo pesado, y artritis reumatoide con tratamiento inadherente con metotrexato quien ingresa por picos febriles y tos con expectoración de 1 mes de duración. Hemograma de ingreso con leucocitosis marcada e hiperbilirrubinemia. Función renal conservada. Al examen físico se valora paciente hemodinámicamente estable con signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral. Debido al estado de inmunosupresión del paciente, cuadro respiratorio e imágenes sugestivas se sospechó infección por tuberculosis. Se solicitaron parámetros para su posterior estudio de cuadro con reporte de 2 baciloscopías negativas para BAAR y PCR para M tuberculosis negativa, por lo que se considera realización de fibrobroncoscopia. Dado el antecedente de artritis reumatoide se solicitó valoración por servicio de neumología para evaluar posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial asociado a patología inmune, a la espera de concepto. Se mantiene hospitalizada bajo manejo antibiótico por posible EPOC exacerbado con sobreinfección bacteriana. Se ordena finalización de terapia RIPE por baciloscopia negativa. Fue valorado por el servicio de neumología quienes ordenan fibrobroncoscopia + LBA para descartar probable micosis pulmonar e infecciones asociadas. Por parte del servicio se ordena broncoscopia a la espera de procedimiento. Se explica conducta a seguir a paciente quien refiere entender y aceptar

Fecha: 27/09/2024: 09:55:02, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

P: 1. Sintomático respiratoria

1.1 Tuberculosis pulmonar a descartar

2. EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado

2.1. Ex Tabaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico

4. Artritis reumatoide en manejo

5. Obesidad

Subjetivo:

Paciente refiere haber pasado buena noche.

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

PA 125/75 mmHg, FC 73 lpm, FR 27 rpm, T 36.1°C, SpO2 99% aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula asistida.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Ojos con secreciones versidad bilateral, esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante pániculo adiposo, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, ausencia de vello

Alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular

5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

23/09/2024

BASILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE

ESPUTO

2 MUESTRAS

NO SE OBSERVA BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

Análisis:

Femenina de 84 años con antecedentes de FA, tabaquismo pesado, y artritis reumatoide con tratamiento inadherente con metotrexate quien ingresa por picos febriles y tos con expectoración de 1 mes de duración. Hemograma de ingreso con leucocitosis marcada e hiperbilirrubinemia. Función renal conservada. Al examen físico se valora paciente hemodinámicamente estable con signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral. Debido al estado de inmunosupresión del paciente, cuadro respiratorio e imágenes sugestivas se sospechó infección por tuberculosis. Se solicitaron paraclínicos para su posterior estudio de cuadro con reporte de 2 baciloscopias negativas para BAAR y PCR para M tuberculosis negativa, por lo que se considera realización de fibrobroncoscopia. Dado el antecedente de artritis reumatoide se solicitó valoración por servicio de neumología para evaluar posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial asociado a patología inmune, a la espera de concepto. Se mantiene hospitalizada bajo manejo antibiótico por posible EPOC exacerbado con sobreinfección bacteriana. Se ordena finalización de terapia RIPE por basilocopia negativa. Fue valorado por el servicio de neumología quienes ordenan fibrobroncoscopia + LBA para descartar probable micosis pulmonar e infecciones asociadas. Por parte del servicio se ordena fibro broncoscopia a la espera de procedimiento. Se explica conducta a seguir a paciente quien refiere entender y aceptar

Fecha: 28/09/2024: 09:28:31, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

P: 1. Sintomático respiratoria

1.1 Tuberculosis pulmonar a descartar

2. EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado

2.1. Ex Tabaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico

4. Artritis reumatoide en manejo

5. Obesidad

Subjetivo:

Pasó buena noche. Sin síntomas miccionales o gastrointestinales, buen patrón de sueño

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

PA 130/80 mmHg, FC 69 lpm, FR 27 rpm, T 36.1°C, SpO2 99% aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula asistida.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Ojos con secreciones versidad bilateral, esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante pánicula adiposa, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, ausencia de vello

Alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular

5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

Análisis:

Femenina de 84 años con antecedentes de FA, tabaquismo pesado, y artritis reumatoide con tratamiento inadherente con metotrexate quien ingresa por picos febriles y tos con expectoración de 1 mes de duración. Hemograma de ingreso con leucocitosis marcada e hiperbilirrubinemia. Función renal conservada. Al examen físico se valora paciente hemodinámicamente estable con signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral. Debido al estado de inmunosupresión del paciente, cuadro respiratorio e imágenes sugestivas se sospechó infección por tuberculosis. Se solicitaron paraclínicos para su posterior estudio de cuadro con reporte de 2 baciloscopias negativas para BAAR y PCR para M tuberculosis negativa, por lo que se considera realización de fibrobroncoscopia. Dado el antecedente de artritis reumatoide se solicitó valoración por servicio de neumología para evaluar posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial asociado a patología inmune, a la espera de concepto. Se mantiene hospitalizada bajo manejo antibiótico por posible EPOC exacerbado con sobreinfección bacteriana. Se ordena finalización de terapia RIPE por basilocopia negativa. Fue valorado por el servicio de neumología quienes ordenan fibrobroncoscopia + LBA para descartar probable micosis pulmonar e infecciones asociadas. Por parte del servicio se ordena fibro broncoscopia a la espera de programación de procedimiento. Se explica conducta a seguir a paciente quien refiere entender y aceptar

Fecha: 29/09/2024: 10:23:39, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

P: 1. Sintomático respiratoria 1.1 Tuberculosis pulmonar a descartar 2. EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado 2.1. Ex Tabaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico 4. Artritis reumatoide en manejo 5. Obesidad

Subjetivo:

Pasó buena noche, no refiere sintomatología

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO: PA:128/70 mmHg, FC:72 lpm, FR:22 rpm, T 36.1°C, SpO2 99% aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59 Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula asistida. Piel normocrómica, sin lesiones. Ojos con secreciones versidad bilateral, esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen con abundante pánicula adiposa, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, ausencia de vello Alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

Análisis:

Femenina de 84 años con antecedentes de FA, tabaquismo pesado, y artritis reumatoide con tratamiento inadherente con metotrexate quien ingresa por picos febriles y tos con expectoración de 1 mes de duración. Hemograma de ingreso con leucocitosis marcada e hiperbilirrubinemia. Función renal conservada. Al examen físico se valora paciente hemodinámicamente estable con signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral. Debido al estado de inmunosupresión del paciente, cuadro respiratorio e imágenes sugestivas se sospechó infección por tuberculosis. Se solicitaron paraclínicos para su posterior estudio de cuadro con reporte de 2 baciloscopias negativas para BAAR y PCR para M tuberculosis negativa, por lo que se considera realización de fibrobroncoscopia. Dado el antecedente de artritis reumatoide se solicitó valoración por servicio de neumología para evaluar posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial asociado a patología inmune, a la espera de concepto. Se mantiene hospitalizada bajo manejo antibiótico por posible EPOC exacerbado

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

con sobreinfección bacteriana. Se ordeno finalización de terapia RIPE por basiloscopia negativa. Fue valorado por el servicio de neumología quienes ordenan fibrobroncoscopia + LBA para descartar probable micosis pulmonar e infecciones asociadas. Por parte del servicio se ordena fibro broncoscopia a la espera de programación de procedimiento. Se explica conducta a seguir a paciente quien refiere entender y aceptar

Fecha: 30/09/2024: 11:10:36, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** ARIEL BELLO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

P: 1. Sintomático respiratoria

1.1 Tuberculosis pulmonar a descartar

2. EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado

2.1. Ex Tabaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico

4. Artritis reumatoide en manejo

5. Obesidad

Subjetivo:

Refiere un patrón de sueño, con mejoría leve de síntomas

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

PA 125/75 mmHg, FC 73 lpm, FR 27 rpm, T 36.1°C, SpO2 99% aire ambiente. Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula asistida.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Ojos con secreciones versidad bilateral, esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante pániculo adiposo, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, ausencia de vello

Alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

Análisis:

Femenina de 84 años con antecedentes de FA, tabaquismo pesado, y artritis reumatoide con tratamiento inadherente con metotrexate quien ingresa por picos febriles y tos con expectoración de 1 mes de duración. Hemograma de ingreso con leucocitosis marcada e hiperbilirrubinemia. Función renal conservada. Al examen físico se valora paciente hemodinámicamente estable con signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral. Debido al estado de inmunosupresión del paciente, cuadro respiratorio e imágenes sugestivas se sospechó infección por tuberculosis. Se solicitaron paradínicos para su posterior estudio de cuadro con reporte de 2 baciloscopias negativas para BAAR y PCR para M tuberculosis negativa, por lo que se considera realización de fibrobroncoscopia. Dado el antecedente de artritis reumatoide se solicitó valoración por servicio de neumología para evaluar posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial asociado a patología inmune, a la espera de concepto. Se mantiene hospitalizada bajo manejo antibiótico por posible EPOC exacerbado con sobreinfección bacteriana. Se ordena finalización de terapia RIPE por basiloscopia negativa. Fue valorado por el servicio de neumología quienes ordenan fibrobroncoscopia + LBA para descartar probable micosis pulmonar e infecciones asociadas. Por parte del servicio se ordena fibro broncoscopia a la espera de procedimiento, para definir instancia hospitalaria. Se explica conducta a seguir a paciente quien refiere entender y aceptar

Fecha: 01/10/2024: 12:30:19, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** ARIEL BELLO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratoria

1.1 Tuberculosis pulmonar a descartar

2. EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado

2.1. Ex Tabaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico

4. Artritis reumatoide en manejo

5. Obesidad

Subjetivo:

Paciente refiere haber pasado buena noche.

Objetivo:

TA 170/84 FC 76 T 36.5 FR 22 SAT 94% Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula asistida.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Ojos con secreciones versidad bilateral, esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, con crepitos bibasales, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante pániculo adiposo, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, ausencia de vello

Alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

23/09/2024

BACILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE

ESPUTO

2 MUESTRAS

NO SE OBSERVA BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

22/09/2024

HEMOGRAMA

LEUCOCITOS 14.72

NEUTROFILOS% 68.3

NEUTROFILOS# 10.05

LINFOCITOS% 16.6

LINFOCITOS# 2.44

MONOCITOS% 10.3

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

MONOCITOS# 1.51
 EOSINOFILOS% 3.08
 EOSINOFILOS# 0.45
 BASOFILOS% 1.81
 BASOFILOS# 0.27
 LUC (Lif. Reactivos, Celulas Grandes no

ERITROCITOS 3.63
 HEMOGLOBINA 11.4
 HEMATOCRITO 32.9

INDICES HEMATICOS
 Volumen Corpuscular Medio (VCM): 90.7
 Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): 31.4
 Concentracion Hb.Corp.Media (CCMH): 34.6
 Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 16.1

SERIE PLAQUETARIA
 Plaquetas (PLT): 404
 Volumen Plaquetario Medio (VPM): 4.92
 Plaquetocrito (PTC): 0.20
 Ancho Distrib. de Plaq.(PDW): 17.21

BILIRRUBINA
 BT 1.04
 BD 0.70
 BI 0.34
 CREATININA 0.75
 NITROGENO 9
 PCR 12.2

GASES ARTERIALES
 PH.....: 7.433
 PCO2 34.0
 PO2 66.9
 HCO3-act 22.2
 HCO3-std 23.2
 BE(B) -1.4
 BE(ecf) -2.1
 ctCO2 23.3
 CO - OXIMETRIA
 Hct 36
 thb 12.4
 sO2 94.2
 FO2Hb 93.2
 FCOHb 1.0
 FMetHb 0.1
 FHHb 5.7
 O2SAT(EST)
 EST. OXIGENACION
 pO2 /FIO2 3.19
 CORREGIDOS
 PH(T).....: 7.448
 PCO2(T) 32.5
 PO2(T) 62.5
 PO2(A-a)(T)
 PO2(a-A)(T)
 RI(T)
 METABOLITOS
 GLU 139
 Lac.....: 2.84
 Temperatura.....: 36.0
 FIO2.....: 21.0
 Bilirrubina.....: <2.0
 AnGap.....: 13.5

21/09/2024
 VIH: 0.11
 TRANSAMINASA GLU 23
 TRANSAMINASA 13
 FOSFATASA ALCALINA 100

20/09/2024
 MYCOBACTERIUM TB: ESPUTO
 COMPLEJO: NO DETECTABLE
 RIFAMPICINA: N/A
 ISONIAZIDA: N/A
 TECNICA: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX ANYPLEX II MTB/ MDR

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

BASILOSCOPIA
 ESPUTO
 MUJCUOPURULENTO
 REPORTE: NO SE OBSERVA BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

19/09/2024

PCR 21.0
 ERITROSEDIMENTACION 36
 NITROGENO 14
 CREATININA 0.79
 SODIO 131
 CLORO 97
 POTASIO 3.8
 GLUCOSA 86
 BILIRRUBINAS
 BT 2.61
 BD 1.54
 BI 1.07

HEMOGRAMA
 LEUCOCITOS 18.57
 NEUTROFILOS% 71.2
 NEUTROFILOS# 13.22
 LINFOCITOS% 12.9
 LINFOCITOS# 2.40
 MONOCITOS% 11.3
 MONOCITOS# 2.09
 EOSINOFILOS% 0.24
 EOSINOFILOS# 0.04
 BASOFILOS% 4.39
 BASOFILOS# 0.82
 LUC (Lif. Reactivos, Celulas Grandes no

ERITROCITOS 3.86
 HEMOGLOBINA 12.2
 HEMATOCRITO 34.8

INDICES HEMATICOS
 Volumen Corpuscular Medio (VCM): 90.3
 Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): 31.5
 Concentración Hb. Corp. Media (CCMH): 34.9
 Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 15.9

SERIE PLAQUETARIA
 Plaquetas (PLT): 341
 Volumen Plaquetario Medio (VPM): 5.17

20/09/2024

ECOGRAFÍA ABDOMINAL TOTAL:
 El Hígado es de forma, tamaño y ecogenicidad normales, sin lesiones focales o difusas
 La Vesícula biliar se encuentra ausente por antecedente quirúrgico pRevio
 La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.
 El Páncreas, los Riñones y el Bazo son de tamaño, forma y ecogenicidad normales
 Los grandes vasos y estructuras retroperitoneales no presentan alteraciones.
 La vejiga es de paredes regulares y no se evidencian ecos en su interior.
 No hay evidencia de líquido libre dentro de la cavidad abdominal.
 CONCLUSION
 Estado post-colecistectomía

20/09/2024

TAC DE TÓRAX:
 Se realiza estudio en equipo multidetector mediante cortes secuenciales axiales desde la entrada torácica hasta el nivel de los diafragmas. Se obtuvo registro con ventana para pulmón y mediastino.
 El parénquima pulmonar presenta opacidades en vidrio deslustrado difusas bilaterales con presencia de formaciones quísticas subpleurales periféricas y hacia la base por neumopatía intersticial crónica. La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.
 Engrosamiento pleural derecho.
 La silueta cardíaca es de tamaño y configuración normales. Los grandes vasos son de calibre, disposición y apariencia usuales.
 El calibre de la vía aérea desde la tráquea hasta los bronquios lobares y segmentarios es adecuado, no hay áreas de estrechez ni compresión extrínseca. El esófago es de paredes delgadas.
 No hay evidencia de adenomegalias en las diferentes estaciones ganglionares.
 La caja torácica no muestra alteraciones.

19/09/2024

RADIOGRAFIA DE TORAX:
 Opacidades en "vidrio esmerilado" a lo largo de ambos hemitórax con tendencia a la consolidación en la base pulmonar derecha.
 Imagen radiolúcida de pared gruesa redondeada bien definida, con diámetro mayor de 34 mm en el ápice pulmonar derecho.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

Tractos atelectásicos en el ápice pulmonar derecho y las bases pulmonares.
Ángulos costodiafrágicos libres.
Crecimiento ventricular izquierdo. Aorta densa y elongada. Dilatación aneurismática del cayado?
Prominencia del hilio pulmonar izquierdo.
Cambios óseos degenerativos.
Osteopenia generalizada

Análisis:

Femenina de 84 años con antecedentes de FA, tabaquismo pesado, y artritis reumatoide con tratamiento inadherente con metotrexate quien ingresa por picos febriles y tos con expectoración de 1 mes de duración. Hemograma de ingreso con leucocitosis marcada e hiperbilirrubinemia. Función renal conservada. Al examen físico se valora paciente hemodinámicamente estable con signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral. Debido al estado de inmunosupresión del paciente, cuadro respiratorio e imágenes sugestivas se sospechó infección por tuberculosis. Se solicitaron paradiagnósticos para su posterior estudio de cuadro con reporte de 2 baciloscopias negativas para BAAR y PCR para M tuberculosis negativa, por lo que se considera realización de fibrobroncoscopia. Dado el antecedente de artritis reumatoide se solicitó valoración por servicio de neumología para evaluar posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial asociado a patología inmune, quienes ordenan fibrobroncoscopia + LBA para descartar probable micosis pulmonar e infecciones asociadas. Se mantiene hospitalizada bajo manejo antibiótico por posible EPOC exacerbado con sobreinfección bacteriana. Se ordena finalización de terapia RIPE por baciloscopia negativa. Por parte del servicio continuamos a la espera de realización de fibrobroncoscopia para definir instancia hospitalaria. Paciente quien desde el día domingo presenta cifras tensionales elevadas, sin antecedente de hipertensión arterial, por lo que se sospecha de HTA de novo, iniciamos manejo antihipertensivo. Se explica conducta a seguir a paciente quien refiere entender y aceptar

Fecha: 02/10/2024: 15:59:34, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

P: 1. Sintomático respiratoria

1.2 1. Enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a autoinmunidad

1.1 Tuberculosis pulmonar descartada

2. EPOC exacerbado Anthonisen III - sobreinfectado

2.1. Ex Tabaquista pesada - Sin diagnóstico espirométrico

4. Artritis reumatoide en manejo

5. Obesidad

6. Hipertensión arterial de novo

Subjetivo:

Paciente refiere haberse sentirse bien

Objetivo:

TA 175/100 MMHG FC 69 LPMT 36.1 °C FR 21 RPM SAT 94% Peso: 65 kg, Talla 1.59

Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula asistida.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Ojos con secreciones versidad bilateral, esclera anictérica, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpandible, no tirajes, con crepitos bibasales, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen con abundante pánicula adiposa, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, ausencia de vello

Alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular

5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

Paradiagnósticos

23/09/2024

BASILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE

ESPUTO

3 MUESTRAS

NO SE OBSERVA BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

BASILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE

ESPUTO

2 MUESTRAS

NO SE OBSERVA BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

22/09/2024

HEMOGRAMA

LEUCOCITOS 14.72

NEUTROFILOS% 68.3

NEUTROFILOS# 10.05

LINFOCITOS% 16.6

LINFOCITOS# 2.44

MONOCITOS% 10.3

MONOCITOS# 1.51

EOSINOFILOS% 3.08

EOSINOFILOS# 0.45

BASOFILOS% 1.81

BASOFILOS# 0.27

LUC (Lif. Reactivos, Celulas Grandes no

ERITROCITOS 3.63

HEMOGLOBINA 11.4

HEMATOCRITO 32.9

INDICES HEMATICOS

Volumen Corpuscular Medio (VCM): 90.7

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

Hemoglobina Corpuscular Media(HCM): 31.4
 Concentracion Hb.Corp.Med (CCMH): 34.6
 Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 16.1

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas (PLT): 404
 Volumen Plaquetario Medio (VPM): 4.92
 Plaquetocrito (PTC): 0.20
 Ancho Distrib. de Pla.(PDW): 17.21

BILIRRUBINA

BT 1.04
 BD 0.70
 BI 0.34
 CREATININA 0.75
 NITROGENO 9
 PCR 12.2

GASES ARTERIALES

PH.....: 7.433
 PCO2 34.0
 PO2 66.9
 HCO3-act 22.2
 HCO3-std 23.2
 BE(B) -1.4
 BE(ecf) -2.1
 ctCO2 23.3
 CO - OXIMETRIA
 Hct 36
 thb 12.4
 sO2 94.2
 FO2Hb 93.2
 FCOHb 1.0
 FMethb 0.1
 FHHb 5.7
 O2SAT(EST)
 EST. OXIGENACION
 pO2 /FIO2 3.19
 CORREGIDOS
 PH(T).....: 7.448
 PCO2(T) 32.5
 PO2(T) 62.5
 PO2(A-a)(T)
 PO2(a-A)(T)
 RI(T)
 METABOLITOS
 GLU 139
 Lac.....: 2.84
 Temperatura.....: 36.0
 FIO2.....: 21.0
 Bilirrubina.....: <2.0
 AnGap.....: 13.5

21/09/2024

VIH: 0.11
 TRANSAMINASA GLU 23
 TRANSAMINASA 13
 FOSFATASA ALCALINA 100

20/09/2024

MYCOBACTERIUM TB: ESPUTO
 COMPLEJO: NO DETECTABLE
 RIFAMPICINA: N/A
 ISONIAZIDA N/A
 TECNICA: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX ANYPLEX II MTB/ MDR

BASIOSCOPIA

ESPUTO
 MUCUOPURULENTO
 REPORTE: NO SE OBSERVA BAAR EN 100 CAMPOS ANALIZADOS

19/09/2024

PCR 21.0
 ERITROSEDIMENTACION 36
 NITROGENO 14
 CREATININA 0.79
 SODIO 131

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

CLORO 97
 POTASIO 3.8
 GLUCOSA 86
 BILIRRUBINAS
 BT 2.61
 BD 1.54
 BI 1.07

HEMOGRAMA
 LEUCOCITOS 18.57
 NEUTROFILOS% 71.2
 NEUTROFILOS# 13.22
 LINFOCITOS% 12.9
 LINFOCITOS# 2.40
 MONOCITOS% 11.3
 MONOCITOS# 2.09
 EOSINOFILOS% 0.24
 EOSINOFILOS# 0.04
 BASOFILOS% 4.39
 BASOFILOS# 0.82
 LUC (Lif. Reactivos, Celulas Grandes no

ERITROCITOS 3.86
 HEMOGLOBINA 12.2
 HEMATOCRITO 34.8

INDICES HEMATICOS
 Volumen Corpuscular Medio (VCM): 90.3
 Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): 31.5
 Concentracion Hb. Corp. Media (CCMH): 34.9
 Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 15.9

SERIE PLAQUETARIA
 Plaquetas (PLT): 341
 Volumen Plaquetario Medio (VPM): 5.17

20/09/2024
 ECOGRAFÍA ABDOMINAL TOTAL:
 El Hígado es de forma, tamaño y ecogenicidad normales, sin lesiones focales o difusas
 La Vesícula biliar se encuentra ausente por antecedente quirúrgico pRevio
 La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.
 El Páncreas, los Riñones y el Bazo son de tamaño, forma y ecogenicidad normales
 Los grandes vasos y estructuras retroperitoneales no presentan alteraciones.
 La vejiga es de paredes regulares y no se evidencian ecos en su interior.
 No hay evidencia de líquido libre dentro de la cavidad abdominal.
 CONCLUSION
 Estado post-colecistectomía

20/09/2024
 TAC DE TÓRAX:
 Se realiza estudio en equipo multidetector mediante cortes secuenciales axiales desde la entrada torácica hasta el nivel de los diafragmas. Se obtuvo registro con ventana para pulmón y mediastino.
 El parénquima pulmonar presenta opacidades en vidrio deslustrado difusas bilaterales con presencia de formaciones quísticas subpleurales periféricas y hacia la base por neumopatía intersticial crónica. La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.
 Engrosamiento pleural derecho.
 La silueta cardíaca es de tamaño y configuración normales. Los grandes vasos son de calibre, disposición y apariencia usuales.
 El calibre de la vía aérea desde la tráquea hasta los bronquios lobares y segmentarios es adecuado, no hay áreas de estrechez ni compresión extrínseca. El esófago es de paredes delgadas.
 No hay evidencia de adenomegalias en las diferentes estaciones ganglionares.
 La caja torácica no muestra alteraciones.

19/09/2024
 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX:
 Opacidades en "vidrio esmerilado" a lo largo de ambos hemitórax con tendencia a la consolidación en la base pulmonar derecha.
 Imagen radiolúcida de pared gruesa redondeada bien definida, con diámetro mayor de 34 mm en el ápice pulmonar derecho.
 Tractos atelectásicos en el ápice pulmonar derecho y las bases pulmonares.
 Ángulos costodiafragmáticos libres.
 Crecimiento ventricular izquierdo. Aorta densa y elongada. Dilatación aneurismática del cayado?
 Prominencia del hilio pulmonar izquierdo.
 Cambios óseos degenerativos.
 Osteopenia generalizada
 Análisis:

Femenina de 84 años con antecedentes de FA, tabaquismo pesado, y artritis reumatoide con tratamiento inadherente con metotrexato quien ingresa por picos febriles y tos con expectoración de 1 mes de duración. Hemograma de ingreso con leucocitosis marcada e hiperbilirrubinemia. Función renal conservada. Al examen físico se valora paciente hemodinámicamente estable con signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral. Debido al estado de inmunosupresión del paciente, cuadro respiratorio e imágenes sugestivas se sospechó infección por tuberculosis. Se solicitaron paraclínicos para su posterior estudio de cuadro con reporte de 2 baciloscopias negativas para BAAR y PCR para M. tuberculosis negativa, por lo que se considera realización de fibrobroncoscopia. Dado el antecedente de artritis reumatoide se solicitó valoración por servicio de neumología para evaluar posibilidad de enfermedad

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

pulmonar intersticial asociado a patología inmune quienes indican fibrobroncoscopia + LBA para descartar probable micosis pulmonar e infecciones asociadas. Paciente en contexto de patología pulmonar intersticial, descartando de momento infección asociada por BAAR, con indicación ambulatoria de realización de estudios espirométricos, de volumen y fibrobroncoscopia, por lo cual, ante evolución favorable, se decide indicar, egreso con formula ambulatoria, control ambulatorio por especialidades tratantes con resultados de estudios solicitados. Se explica conducta a seguir a paciente quien refiere entender y aceptar

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Fecha: 02/10/2024

- 893806 - CAPACIDAD DE DIFUSION CON MONOXIDO DE CARBONO - ESPIROMETRIA SIMPLE - Cantidad: 1
- 879301 - TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX - Cantidad: 1
- 893701 - VOLUMENES PULMONARES POR PLETISMOGRAFIA, PRE Y POST BRONCODILATADORES - Cantidad: 1
- 332203 - BRONCOSCOPIA CON LAVADO BRONCOALVEOLAR - Cantidad: 1
- 890354 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA - Cantidad: 1
- 893805 - ESPIROMETRIA O CURVA DE FLUJO VOLUMEN PRE Y POST BRONCODILATADORES - Cantidad: 1
- 332903 - EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO DE BRONQUIO O PULMON POR TORACOSCOPIA - FIBROBRONCOSCOPIA PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO - Cantidad: 1
- 890371 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA - Cantidad: 1

Fecha: 19/09/2024

- 903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - Cantidad: 1
- 871121 - RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) - Cantidad: 1
- 903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903839 - GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) - Cantidad: 1
- 902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1
- 903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
- 903813 - CLORO - Cantidad: 1
- 907106 - UROANALISIS - Cantidad: 1
- 906913 - PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 903841 - GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA - Cantidad: 1
- 902204 - ERITROSEDIMENTACION [VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR VSG] MANUAL - Cantidad: 1
- 881302 - ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y FLANCOS) - Cantidad: 1
- 903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 20/09/2024

- 901101 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL-RESISTENTE [ZIEHL-NEESEN]- Cantidad: 1
- 895100 - ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD - Cantidad: 1
- 908825 - Mycobacterium tuberculosis IDENTIFICACION REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA - Cantidad: 1
- 879301 - TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX - Cantidad: 1
- 901230 - MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO - Cantidad: 1

Fecha: 21/09/2024

- 903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1
- 903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1
- 906249 - VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS - Cantidad: 1
- 903833 - FOSFATASA ALCALINA - Cantidad: 1
- 903839 - GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) - Cantidad: 1

Fecha: 22/09/2024

- 903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1
- 903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - Cantidad: 1
- 902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 903839 - GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) - Cantidad: 1
- 906913 - PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
- 903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 23/09/2024

- 901101 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL-RESISTENTE [ZIEHL-NEESEN]- Cantidad: 4

Fecha: 24/09/2024

- 890471 - INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA - Cantidad: 1

Fecha: 26/09/2024

- 332903 - EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO DE BRONQUIO O PULMON POR TORACOSCOPIA - FIBROBRONCOSCOPIA PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO - Cantidad: 1

Fecha: 27/09/2024

- 332203 - BRONCOSCOPIA CON LAVADO BRONCOALVEOLAR - Cantidad: 1

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Fecha: 01/10/2024

- MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
- B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
- A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1

Fecha: 02/10/2024

- MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
- C09CA01 - LOSARTAN POTASICO - Cantidad: 7200
- LOSARTAN - LOSARTAN POTASICO - Cantidad: 1
- B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
- HUCCAT41 - CATETER INTRACAT# 22 - Cantidad: 1
- IN5427 - Bromuro de ipratropio Solución nebulizar - Cantidad: 1
- HUCCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

-0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 1
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 19
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 22
 Fecha: 25/09/2024
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXTEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -J01CA028721 - Ampicilina sódica + Sulbactam sódico - Cantidad: 8
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 11
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 4
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 3
 -HUCCAT41 - CATETER INTRACAT# 22 - Cantidad: 1
 -IM6134 - TERMOMETRO DIGITAL - Cantidad: 1
 -10099 - (MINIBAG PLUS) CLORURO DE SODIO AL 9% CON ADAPTADOR - Cantidad: 4
 -10055 - PIPERACILINA + TAZOBACTAM - Cantidad: 11
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 16
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 10
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 3
 Fecha: 26/09/2024
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 4
 -10055 - PIPERACILINA + TAZOBACTAM - Cantidad: 4
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 4
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 4
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 Fecha: 27/09/2024
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -10099 - (MINIBAG PLUS) CLORURO DE SODIO AL 9% CON ADAPTADOR - Cantidad: 4
 -10055 - PIPERACILINA + TAZOBACTAM - Cantidad: 4
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 2
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 4
 -HUCCAT41 - CATETER INTRACAT# 22 - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 Fecha: 28/09/2024
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 4
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 Fecha: 30/09/2024
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 2
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 8
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2

Medidas Generales Ordenadas:

Fecha: 01/10/2024
 Indicaciones:
 HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN INDIVIDUAL
 AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 MASCARILLA N95 PERMANENTE
 OXIGENO POR CÁNULA NASAL A 3 LITROS/MIN PARA SAO2 >90%
 DIETA NORMAL
 TAPÓN VENOSO

LOSARTAN TAB 50MG VO CADA DÍA
 PIRIDOXINA TABLETA 50 MG, DAR 1 TAB VO CADA DÍA
 ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DÍA
 ACETAMINOFÉN 1 G VO CADA 12 HRS POR RAZÓN NECESARIA
 BROMURO DE IPRATROPIO 4 PUFF CADA 8 HORAS

CURVA TÉRMICA CADA 4 HORAS
 CUIDADOS DE ENFERMERÍA
 CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

PENDIENTES:
 FIBROBRONCOSCOPIA FS:27/09/2024

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

Fecha: 02/10/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

MASCARILLA N95 PERMANENTE

OXÍGENO POR CÁNULA NASAL A 3 LITROS/MIN PARA SAO₂ >90%

DIETA NORMAL

TAPÓN VENOSO

LOSARTAN TAB 50MG VO CADA 12 HORAS

PIRIDOXINA TABLETA 50 MG, DAR 1 TAB VO CADA DÍA

ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DÍA

ACETAMINOFÉN 1 G VO CADA 12 HRS POR RAZÓN NECESARIA

BROMURO DE IPRATROPIO 4 PUFF CADA 8 HORAS

SE SOLICITA ELECTROCARDIOGRAMA

CURVA TÉRMICA CADA 4 HORAS

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

PENDIENTES:

FIBROBRONCOSCOPIA FS: 27/09/2024

Fecha: 02/10/2024

Indicaciones:

Alta medica

Losartan tabletas 50mg VO cada 12 horas por dos meses

Piridoxina tableta 50 mg dar 1 tab VO cada día por 3 semanas

Acetaminofén 1 g VO cada 12 hrs por 5 días en caso de dolor

Bromuro de ipratropio 4 PUFF cada 8 horas por dos meses

Pruebas de función pulmonar (ambulatorio)

Fibrobroncoscopia (ambulatoria)

Lavado broncoalveolar (ambulatorio)

Tomografía computarizada de tórax (ambulatorio)

Cita control con el servicio de infectología con resultados (ambulatorios)

Cita control con el servicio de neumología con resultados (ambulatorios)

Recomendaciones y signos de alarma: dificultad para respirar, si se pone azul, se le hunden las costillas, presencia de fiebre que no mejore con medicamentos, presencia de dolor que no mejore con analgesia, presencia de sangrado.

Fecha: 19/09/2024

Indicaciones:

OBSERVACIÓN

DIETA A TOLERANCIA

LACTATO RINGER A RAZÓN DE 60 CC/H

PARACETAMOL 1 GR IV AHORA

HIOSCINA AMP 20 MG IV AHORA

SS/ HEMOGRAMA, PCR, VSG, BUN, CREATININA, IONOGRAMA, GLUCOSA SUERO, BILIRRUBINAS, UROANÁLISIS

SS/ RX DE TÓRAX

REVALORAR

CSV Y AC

Fecha: 19/09/2024

Indicaciones:

OBSERVACIÓN

DIETA A TOLERANCIA

LACTATO RINGER A RAZÓN DE 60 CC/H

PARACETAMOL 1 GR IV CADA 8 HORAS

HIOSCINA AMP 20 MG IV CADA 8 HORAS

SS/ GASES ARTERIALES, ECOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL

SS/ VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA

CSV Y AC

Fecha: 20/09/2024

Indicaciones:

Hospitalizar en habitación individual

Aislamiento respiratorio

Dieta normal

Tapón venoso

Ampicilina/sulbactam 3 gr iv cada 6 horas fi: 20/09/2024

Clarithromicina tab 500 mg vo cada 12 hrs FI 20/09/2024

Acetaminofén 1 g vo cada día

Enoxaparina 40 mg sc cada día

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

Pendiente PCR para mycobacterium tuberculosis, baciloscopias seriadas, cultivo para mycobacterium tuberculosis
 Curva térmica cada 4 horas
 Cuidados de enfermería
 Registrar signos vitales y avisar cambios

Fecha: 20/09/2024
 Indicaciones:
 Hospitalizar en sala general.
 Dieta normal
 Tapón venoso

Ampicilina/sulbactam 3 gr iv cada 6 horas fi: 20/09/2024
 Acetaminofen 1 g vo cada día
 Enoxaparina 40 mg sc cada día

SS/ TAC de tórax simple
 SS/ PCR para mycobacterium tuberculosis, baciloscopias seriadas, cultivo para mycobacterium tuberculosis
 S/S Electrocardiograma
 P/ uroanálisis

Curva térmica cada 4 horas
 Cuidados de enfermería
 Registrar signos vitales y avisar cambios

Fecha: 21/09/2024
 Indicaciones:
 Hospitalizar en habitación individual
 Aislamiento respiratorio
 Mascarilla N95 permanente
 Dieta normal
 Tapón venoso

Ampicilina/sulbactam 3 gr iv cada 6 horas fi: 20/09/2024
 Claritromicina tab 500 mg vo cada 12 hrs FI 20/09/2024:::suspender:::
 Acetaminofén 1 g vo cada día
 Enoxaparina 40 mg sc cada día
 Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg + Pirazinamida 400 mg + Etambutol 275 mg tableta, administrar 4 tabletas VO cada día por 56 dosis
 Piridoxina tableta 50 mg, dar 1 tab VO cada día por 30 días (dosis 1/30)

Se solicita
 -VIH
 -AST, ALT, fosfatasa alcalina
 -Gases arteriales

Pendientes
 -PCR para mycobacterium tuberculosis
 -Baciloscopias seriadas X2
 -Cultivo para mycobacterium tuberculosis

Curva térmica cada 4 horas
 Cuidados de enfermería
 Registrar signos vitales y avisar cambios

Fecha: 22/09/2024
 Indicaciones:
 Hospitalizar en habitación individual
 Aislamiento respiratorio
 Mascarilla N95 permanente
 Oxígeno por cánula nasal a 3 litros/min para Sao2 >90% :::::NUEVO::::
 Dieta normal
 Tapón venoso

Ampicilina/sulbactam 3 gr iv cada 6 horas fi: 20/09/2024 :::::suspender:::
 Claritromicina tab 500 mg vo cada 12 hrs FI 20/09/2024:::suspender:::
 Piperacilina tazobactam 4,5 gramos IV cada 6 horas :::::FI: 22/09/2024:::NUEVO
 Bromuro de ipratropio 4 puff cada 20 minutos por 1 hora y luego cada hora por 3 horas, luego continuar 4 puff cada 8 horas :::::NUEVO:::
 :::::

Acetaminofén 1 g vo cada día
 Enoxaparina 40 mg sc cada día
 TERAPIA RIPE: Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg + Pirazinamida 400 mg + Etambutol 275 mg tableta, administrar 4 tabletas VO cada día por 56 dosis Piridoxina tableta 50 mg, dar 1 tab VO cada día por 30 días (dosis 1/30)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

Se solicita

-Hemograma, gases arteriales, bilirrubinas, azoados

Curva térmica cada 4 horas

Cuidados de enfermería

Registrar signos vitales y avisar cambios

Pendientes

-PCR para mycobacterium tuberculosis

-Cultivo para mycobacterium tuberculosis

Fecha: 23/09/2024

Indicaciones:

Hospitalizar en habitación individual

Aislamiento respiratorio

Mascarilla N95 permanente

Oxígeno por cánula nasal a 3 litros/min para Sao2 >90%

Dieta normal

Tapón venoso

Piperacilina tazobactam 4,5 gramos IV cada 6 horasFI: 22/09/2024.....NUEVO

TERAPIA RIPE: Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg + Pirazinamida 400 mg + Etambutol 275 mg tableta, administrar 4 tabletas VO cada día por 56 dosis

Piridoxina tableta 50 mg, dar 1 tab VO cada día

Enoxaparina 40 mg sc cada día

Acetaminofén 1 g vo cada 12 hrs por razón necesaria

Bromuro de ipratropio 4 puff cada 8 horas

Curva térmica cada 4 horas

Cuidados de enfermería

Registrar signos vitales y avisar cambios

Se solicita:

valoración por infectología

Pendientes:

-PCR para mycobacterium tuberculosis

-Cultivo para mycobacterium tuberculosis

- Baciloscopias x2

Fecha: 24/09/2024

Indicaciones:

Hospitalizar en habitación individual

Aislamiento respiratorio

Mascarilla N95 permanente

Oxígeno por cánula nasal a 3 litros/min para Sao2 >90%

Dieta normal

Tapón venoso

Piperacilina tazobactam 4,5 gramos IV cada 6 horasFI: 22/09/2024..... D2/7

TERAPIA RIPE: Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg + Pirazinamida 400 mg + Etambutol 275 mg tableta, administrar 4 tabletas VO cada día por 56 dosis

Piridoxina tableta 50 mg, dar 1 tab VO cada día

Enoxaparina 40 mg sc cada día

Acetaminofén 1 g vo cada 12 hrs por razón necesaria

Bromuro de ipratropio 4 puff cada 8 horas

Curva térmica cada 4 horas

Cuidados de enfermería

Registrar signos vitales y avisar cambios

Pendientes:

-PCR para mycobacterium tuberculosis

-Cultivo para mycobacterium tuberculosis

- Baciloscopias No 3

- valoración por infectología

Fecha: 25/09/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

MASCARILLA N95 PERMANENTE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

OXÍGENO POR CÁNULA NASAL A 3 LITROS/MIN PARA SAO₂ >90%
DIETA NORMAL
TAPÓN VENOSO

PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5 GRAMOS IV CADA 6 HORAS :.....FI: 22/09/2024:..... D3/7
TERAPIA RIPE: RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TABLETA, ADMINISTRAR 4
TABLETAS VO CADA DÍA POR 56 DOSIS
PIRIDOXINA TABLETA 50 MG, DAR 1 TAB VO CADA DÍA
ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DÍA
ACETAMINOFÉN 1 G VO CADA 12 HRS POR RAZÓN NECESARIA
BROMURO DE IPRATROPIO 4 PUFF CADA 8 HORAS

CURVA TÉRMICA CADA 4 HORAS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
REGISTRAR SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

PENDIENTES:
- BACILOSCOPIA NO 3
- VALORACIÓN POR NEUMOLOGÍA

Fecha: 26/09/2024
Indicaciones:
HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN INDIVIDUAL
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
MASCARILLA N95 PERMANENTE
OXÍGENO POR CÁNULA NASAL A 3 LITROS/MIN PARA SAO₂ >90%
DIETA NORMAL
TAPÓN VENOSO

PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5 GRAMOS IV CADA 6 HORAS :.....FI: 22/09/2024:..... D6/7
TERAPIA RIPE: RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TABLETA, ADMINISTRAR 4
TABLETAS VO CADA DÍA POR 56 DOSIS
PIRIDOXINA TABLETA 50 MG, DAR 1 TAB VO CADA DÍA
ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DÍA
ACETAMINOFÉN 1 G VO CADA 12 HRS POR RAZÓN NECESARIA
BROMURO DE IPRATROPIO 4 PUFF CADA 8 HORAS

S/ FIBROBRONCOSCOPIA

CURVA TÉRMICA CADA 4 HORAS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
REGISTRAR SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

PENDIENTES:
- BACILOSCOPIA NO 3 **YA**
- VALORACIÓN POR NEUMOLOGÍA **YA**

Fecha: 27/09/2024
Indicaciones:
HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN INDIVIDUAL
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
MASCARILLA N95 PERMANENTE
OXÍGENO POR CÁNULA NASAL A 3 LITROS/MIN PARA SAO₂ >90%
DIETA NORMAL
TAPÓN VENOSO

PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5 GRAMOS IV CADA 6 HORAS :.....FI: 22/09/2024:..... D7/7 :: SUSPENDER ::
TERAPIA RIPE: RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TABLETA, ADMINISTRAR 4
TABLETAS VO CADA DÍA POR 56 DOSIS
PIRIDOXINA TABLETA 50 MG, DAR 1 TAB VO CADA DÍA
ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DÍA
ACETAMINOFÉN 1 G VO CADA 12 HRS POR RAZÓN NECESARIA
BROMURO DE IPRATROPIO 4 PUFF CADA 8 HORAS

CURVA TÉRMICA CADA 4 HORAS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
REGISTRAR SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

PENDIENTES:
PTE FIBROBRONCOSCOPIA FS:27/09/2024

Fecha: 28/09/2024
Indicaciones:
HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

ASLAMIENTO RESPIRATORIO
MASCARILLA N95 PERMANENTE
OXÍGENO POR CÁNULA NASAL A 3 LITROS/MIN PARA SAO₂ >90%
DIETA NORMAL
TAPÓN VENOSO

TERAPIA RIPE: RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TABLETA, ADMINISTRAR 4 TABLETAS VO CADA DÍA POR 56 DOSIS
PIRIDOXINA TABLETA 50 MG, DAR 1 TAB VO CADA DÍA
ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DÍA
ACETAMINOFÉN 1 G VO CADA 12 HRS POR RAZÓN NECESARIA
BROMURO DE IPRATROPIO 4 PUFF CADA 8 HORAS

CURVA TÉRMICA CADA 4 HORAS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
REGISTRAR SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

PENDIENTES:
PTE FIBROBRONCOSCOPIA FS:27/09/2024

Fecha: 29/09/2024
Indicaciones:
HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN INDIVIDUAL
ASLAMIENTO RESPIRATORIO
MASCARILLA N95 PERMANENTE
OXÍGENO POR CÁNULA NASAL A 3 LITROS/MIN PARA SAO₂ >90%
DIETA NORMAL
TAPÓN VENOSO

TERAPIA RIPE: RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TABLETA, ADMINISTRAR 4 TABLETAS VO CADA DÍA POR 56 DOSIS
PIRIDOXINA TABLETA 50 MG, DAR 1 TAB VO CADA DÍA
ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DÍA
ACETAMINOFÉN 1 G VO CADA 12 HRS POR RAZÓN NECESARIA
BROMURO DE IPRATROPIO 4 PUFF CADA 8 HORAS

CURVA TÉRMICA CADA 4 HORAS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
REGISTRAR SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

PENDIENTES:
PTE FIBROBRONCOSCOPIA FS:27/09/2024

Fecha: 30/09/2024
Indicaciones:
HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN INDIVIDUAL
ASLAMIENTO RESPIRATORIO
MASCARILLA N95 PERMANENTE
OXÍGENO POR CÁNULA NASAL A 3 LITROS/MIN PARA SAO₂ >90%
DIETA NORMAL
TAPÓN VENOSO

TERAPIA RIPE: RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TABLETA, ADMINISTRAR 4 TABLETAS VO CADA DÍA POR 56 DOSIS
PIRIDOXINA TABLETA 50 MG, DAR 1 TAB VO CADA DÍA
ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DÍA
ACETAMINOFÉN 1 G VO CADA 12 HRS POR RAZÓN NECESARIA
BROMURO DE IPRATROPIO 4 PUFF CADA 8 HORAS

CURVA TÉRMICA CADA 4 HORAS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
CONTROL DE SIGNOS VITALES, AVISAR CAMBIOS

PENDIENTES:
PTE FIBROBRONCOSCOPIA FS:27/09/2024

Fecha: 30/09/2024
Indicaciones:
TERAPIA RIPE: RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TABLETA, ADMINISTRAR 4 TABLETAS VO CADA DÍA POR 56 DOSIS

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

LO DESCRITO

Complicaciones:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:08:14 p. m.

Admisión: AD1005930

Administradora: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS

Paciente: MAXIMA BELLO BATISTA

EPICRISIS

NINGUNA

Servicio de Egreso: 000014|Hospitalización 4to Piso

Fecha de Egreso: 02/10/2024 16:31

Motivo de Salida: Alta

Estado a la Salida: Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: A161 : TUBERCULOSIS DEL PULMON, SIN EXAMEN BACTERIOLOGICO E HISTOLOGICO

Diagnóstico Relacionado 1: M069 : ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA

Diagnóstico Relacionado 2: J441 : ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR MEDICINA:**Tratamiento Farmacológico:**

Alta medica

Losartan tabletas 50mg VO cada 12 horas por dos meses

Piridoxina tableta 50 mg dar 1 tab VO cada día por 3 semanas

Acetaminofén 1 g VO cada 12 hrs por 5 días en caso de dolor

Bromuro de ipratropio 4 PUFF cada 8 horas por dos meses

Pruebas de función pulmonar (ambulatorio)

Fibrobroncoscopia (ambulatoria)

Lavado broncoalveolar (ambulatorio)

Tomografía computarizada de tórax (ambulatorio)

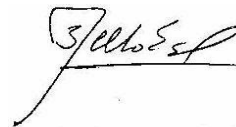
Cita control con el servicio de infectología con resultados (ambulatorios)

Cita control con el servicio de neumología con resultados (ambulatorios) .

Recomendaciones Adicionales:

Recomendaciones y signos de alarma: dificultad para respirar, si se pone azul, se le hunden las costillas, presencia de fiebre que no mejore con medicamentos, presencia de dolor que no mejore con analgesia, presencia de sangrado

Aplica Cuidados de Enfermería: No

ARIEL ALONSO BELLO ESPINOSA
MEDICINA INTERNA

CC.73094962 - RM.RM 0014 - CC 73094962